EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 77220
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-01-11 13:53:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LIDIA POO GONZALEZ			**RUN**	: 2.142.901-5
F.Nac	: 02-04-1920	**Edad**	: 103 AÑOS, 9 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: HOGAR DE FAMILIA			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-01-05	**Fecha Egreso**	: 2024-01-11 13:53:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J20.9-BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Traslado a Hodom

Diagnosticos

-Neumonia Multifocal
-Klebsiella Pneumoniae Blee
-SAMS
-Insuficiencia respiratoria resuelta.
-Antecedentes de EPOC (cesfam) / Biomasa?
-Hipokalemia en recuperacion (secundario a tazonam)
-HTA
-Insuficiencia Cardiaca??
-ACV secuelada
-Incontinencia urinaria
-Institucionalizada / Dependencia total
-Enf Alzheimer
-Epilepsia Secundaria
-Equimosis y Flebitis ESI
-Tno Deglutorio en rehabilitacion.
-Delirium en recuperacion

Historia Ingreso:

Paciente Femenina De 103 Años Institucionalizada Dependencia Total Con Antecedentes Mórbidos Hipertensión Arterial - Acv Secuelado - Incontinencia Urinaria.- Enf Alzheimer - Epilepsia Secundaria Sin Alergia Conocidas.
Es Traida Por Presentar Compromiso Del Estado Gneral, Disnea , Desaturación
De 48 Horas De Evolución Por Que Se Apoya Con Oxigeno Alto Flujo .
Se Realiza Exámenes De Laboratorio Pcr 88 Leucocitos 14000
Lactato : 1,2 Creatinina : 0,70 Sodio (Na) : 143,00 Potasio (K) : 4,20 Mmol/L Cloro (Cl) : 106,00,

Se solicita AngioTAC negativo para TEP / Condensaciones multifocales .
Con regular respuesta a ceftriaxona durane primeras 48 horas por lo que se inicia Tazonam y se solicitan cultivos secrecion bronquial.
Evoluciona favorablemente con Tazonam y se rescata cultivo el dia 11/1 porisivo pta Klebsiella Pneumoniae BLEE susceptible a tazonam y carbapenemicos.
Se instaura tratamiento con Ertapenem con intenciones de continuar tratamiento por Hodom.
El dia 10/1/23 ya sin necesidades de oxigeno , mucho mas contectada con el medio. Parametros inflamatorios en franco descenso.
Durante hospitalizacion con alimentacion por via enteral x SNE, se solicita rehabilitacion fonoaudiologica por Hodom para alimentacion via oral.
Al dia 11/1/23 en condiciones de continuar manejo en Hodom.

PLAN DE MANEJO:

Planes:
-Neumonia: Ertapenem por 7 dias / KNT respiratoria motora
-I. Respiratoria: resuelta.
-Hipokalemia : Slow-K via enteral , control potasio en 48h
-Flebitis: Observacion y tratamiento atb ya instaurado.
-Tno deglutorio: Rehabilitacion fonoaudiologica
-Delirium: Intentar disminucion de dosis de medicamentos. Suspension primero de Zolpidem y uego puede quedar
con dosis bajas de quetiapina y mantener trazodona nocturna.

INDICACIONES AL ALTA

1. Indicaciones
2.
3. -Regimen x SNE segun nutricion.
4. -Reposo Relativo
5. -Terapia fonoaudiologica , rehabilitacion deglucion .
6. -Kinesioratepia respiratoria y Motora segun ev por kinesiologia.
7. -Ertapenem 1g ev al dia (1/7)
8. -Ipratropio 4 puff cada 6 horas
9. -Budesonida 2 puff cada 12 horas (cronico)
10. -Atorvastatina 20mg x sne (cronico)
11. -Omeprazol 20mg x sne (cronico)
12. -Calcio + VitD 1 al dia x sne (cronico)
13. -Memantina 10mg c 12 x sne
14. -Sertralina 100mg x sne x dia
15. -Espironolactona 25mg al dia x sne
16. -Ac Folico 5mg x sne x dia (cronico)
17. -Ferranim 1 al dia x sne
18. -Slow-k 1 cada 8 horas x sne
19. -Quetiapina 50mg pm SOS
20. -Zolpidem Suspender
21. -Trazodona 100mg x noche
22. -Control elp en 48 hrs

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-N

JEFE SERVICIO